

إسم المريض ربيعاً : نادية ساويرس داود سليمان
المحافظة : القاهرة
رقم البطاقة : 27604052401547 رقم التليفون : 01220639000
العمر(تاريخ الميلاد) : 05-04-1976 المهنة : بدون عمل
العنوان : 4ش رمضان السيد عبيد
تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- /د ----- /د ----- /د.ا ----- /د.ا

ملاحظات : ---

المجلس الطبي المتخصص

Name: نادية ساويرس داود سليمان
National ID: 27604052401547



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين





مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

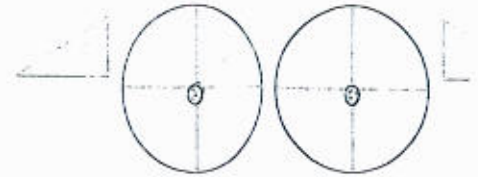
نشرة

٢٠٢٢/١٢/٢٠

MDT FORM

٥٨٢٦
٢٠٢٢

Name	نادية سامر حسن
Age	45
MRN	١٢٠١٥٨٤٤٨٥
ID	٢٧٦٠٤٥٤٤١٥٤٧
Co morbidity	Thalassemia



Clinical Data

Bx:	SM:
IHC: ER: 5/2 PR: 5/2 Her2: -ve Ki67: 30%	Mets Workup: -ve
pT ₁ N _{1a} M ₀ (4c)	
COMMENT: Left BCS 21/12/2020 → adjuvant chemo AC x 4 (500mg x 12 ended 6/2021	

MDT OUTCOME & PLAN

- For PORT (40 Gy/20 Fr + Boost (10 Gy/5 Fr/1w)
- Adjuvant hormonal HT

MDT-Form
Revision
10/2020
10/2020

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

Name: ناديه ساويرس داود		
MR. : 1719		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 48-year-old individual with a history of thalassemia who underwent upfront surgery for a ypT1N1, luminal B breast carcinoma. Post-operative management included adjuvant chemotherapy administered via a port and hormonal therapy with tamoxifen initiated in September 2021, along with supportive therapy provided by the pharmacy for a duration of two months. The patient continues tamoxifen 20 mg daily, with the current prescription intended for a three-month supply. Investigations have been ordered, and the next follow-up visit is scheduled for three months from now.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	Rana Essam
يعتمد ,		



Patient Name: Nadia Sawires Dawood Soliman	Date : 07/12/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 5836/2020	Pat. ID: 17979

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast UIQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast UIQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with post-operative seroma clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

07/12/2023 2:46 PM



Patient Name: Nadia Sawires Dawood Soliman	Date : 14/09/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 47 Year(s)
Medical ID: 5836/2020	17979

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS: -**

Compared to previous study dated 28.8.2022 the current study shows:

Chest:

- Still noted left breast operative bed small seroma
- No sizable suspicious pulmonary nodules or masses
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Dense multiple gall bladder stones are noted
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Few prominent porta hepatis and porto-caval lymph nodes.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed no suspicious lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

Known case of breast cancer showing:

- ***No newly developed pulmonary or hepatic metastatic deposits.***
- ***Calcular gall bladder***

Dr. Aya Deabes, FRCR

Dr. Amr Farouk, M.D.

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2022-12-13

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) نادية ساويرس داود سليمان بطاقة رقم 27604052401547
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2022-12-13

الموظف المختص
سماح محمود



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،

مسلسل 251095

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Name : nadia sweers dawood

Date : 22-11-2020

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -

Chest:

- Known case of breast cancer showing:
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Dense multiple gall bladder stones are noted
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Right adenexal hypodense cyst measures about 3.8x3cm
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed no lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

- ***Known case of breast cancer showing no definite hepatic focal lesion or metastatic pulmonary nodules***
- ***Hepatomegaly***
- ***Calcular gall bladder***
- ***Right adenexal hypodense cyst for ultrasound correlation***

DR.M.GOMAA,MD



Pathology Report

Name: نادية ساويرس داوود

Age: 45 years.

Clinical data: Left breast mass

Specimen type: WLE with LNs.

Date(received) : 12/12/2020

Date(reported) : 21/12/2020

Lab. Number: 2050

Hospital Number: /2020

Gross Description:

Two specimens :

1-A sector of breast tissue 10x9x4cm, serial cuts revealed an ill-defined firm greyish white mass 1.7x1.5cm, located (4.5cm, 3.5cm, 4.5cm, 4cm, and 0.7cm) from (lateral, medial, superior, inferior, superficial and deep) margins respectively.
sparely received a piece of fibro fatty tissue piece 4x2.5cm (deep margin) grossly unremarkable.

2-Sentinel L.Ns: two blue stained nodes 3x2cm and 2.3x1.4cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed breast tissue infiltrated by invasive, malignant tumor formed of nests and trabeculae of moderately anaplastic ductal epithelial cells with desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Left breast mass WLE with LNs

Invasive duct carcinoma grade 2.

focal lymphatic tumor emboli

minimal in situ component

free margins

nodal deposits in (1/2) SLN with no capsular invasion.

Stage p T1 p N1a.

Prof. Dr. Amal Haredi

Dr. Enas Mohammed ali



Patient Name : الأستاذة / نادية ساويرس داود سليمان
Patient No. : 27604052401547
Path No. : 2300/22
Sex : Female
Age : 46 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004537
Request Date : 13/08/2022
Verification Date : 23/08/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : dr.Enas

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast mass.

Nature of the specimen:

Tru-Cut biopsy (received at 09/08/22).

Gross Examination:

Multiple greyish white tissue cores, up to 0.5cm long. Totally submitted.

Microscopic examination:

- Histological type: Fat necrosis.
- Additional pathologic findings: No.

Diagnosis:

Left breast mass; Tru-Cut biopsy:
-Fat necrosis.

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :

abdelrahman ibrahim

Printing Date : 26/05/2025 10:47:07

Page 1 of 1

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt